G1 — Transpiration anormale · Entraînement Type A · Réflexe SSP · v3

LOT_001 audité · Phase A + Phase B (DX.1–15) · 51 questions Type A, 5 options · examen fédéral CH (CK) · 34 EX · 10 AP · 7 SPE

🧭 Carte mentale G1 · 60 secondes avant de répondre

EX **Examen** — vignette type examen fédéral CK : décision clinique, 5 options. Priorité absolue.

AP **Approfondissement** — mécanismes, nuances, raisonnement enrichi. Texte en bleu.

SPE · spécialité **Spécialiste** — niveau spécialité. Touchez 🔥 quand une question vous passionne : le score dira quelle spécialité vous exalte.

Version papier : répondez d'abord ; le corrigé commenté est en annexe, après la dernière question. Version écran : choisissez une option → elle se marque **juste** ou **fausse**. Le commentaire ne s'ouvre **que** si vous touchez 💡.

Les 3 questions réflexes devant tout patient qui transpire

1. **Danger maintenant ?** Malaise, confusion, oppression, dyspnée, chaleur → fonctions vitales, **glycémie**, **ECG en 10 min**, refroidir.
2. **Quel profil ?** Focale-bilatérale-ancienne-jamais la nuit (primaire) *ou* généralisée / asymétrique / nocturne / après 25 ans (secondaire).
3. **Quel signe associé désigne la famille, et quel examen tranche ?** Une hypothèse = un examen qui prouve.

⏱️ Temporalité

- Minutes, avec malaise → hypoglycémie, SCA (urgence)
- Accès de 10–30 min → panique, phéochromocytome, bouffée, flush
- Nocturne → fièvre, ménopause, TB, lymphome, apnées, médicament
- 6–72 h après le dernier verre → sevrage
- Depuis l'adolescence, jamais la nuit → primaire

📍 Topographie

- Focale bilatérale symétrique (aisselles, paumes, plantes, visage) → primaire (≥ 4/7 critères)
- Généralisée ou asymétrique → secondaire (DX.10)
- Peau **sèche** à la chaleur + confusion → anhidrose, coup de chaleur

🔗 Signes associés → examen qui tranche

- Faim, tremblement, confusion sous traitement → glycémie capillaire
- Fièvre + défaillance → hémocultures, hôpital ; + prothèse/souffle → 3 hémocultures, ETT puis ETO
- Toux, exposition, perte de poids → 2 expectorations (PCR, culture)
- Adénopathie > 4–6 sem + symptômes B → biopsie-exérèse
- Thermophobie, tachycardie, amaigrissement → TSH (réflexe fT4/T3)
- Céphalée, palpitations, **pâleur**, HTA par accès → métanéphrines libres
- Flush **sec** + diarrhée/sibilances → 5-HIAA 24 h ×2
- Bouffée **humide**, cycles irréguliers, ≥ 45 ans → clinique

🗒️ Contexte

- Médicaments : ISRS, insuline, bêtabloquants, AINS, agonistes dopaminergiques (début, arrêt, dose)
- Alcool : quantité, heure du dernier verre
- Poids, IMC ≥ 30, tour de cou, ronflements → apnées
- Origine à forte incidence TB, risque VIH, prothèse valvulaire, drogues IV
- Âge : début > 25 ans ou > 60 ans → secondaire plus probable

🚩 Ordre d'exclusion (délai avant dommage irréversible)

1. Hors liste : **SCA** — ECG 10 min
2. Hors liste : **coup de chaleur** — 144, refroidir
3. E1 Hypoglycémie du diabétique traité (DX.4)
4. E2 Infection fébrile avec défaillance (DX.9)
5. E3 Endocardite, VIH (DX.14)
6. E4 Sevrage alcoolique compliqué (DX.6)
7. E5 Thyrotoxicose décompensée (DX.7)
8. E6 Phéochromocytome (DX.13)
9. E7 Tuberculose (DX.11)
10. E8 Lymphome (DX.12)
11. E9 Tumeur carcinoïde (DX.15)
12. Puis fréquents : ménopause, anxiété, obésité, primaire, médicament

① Raisonner · 13 Q · avant de nommer le diagnostic

Triage, prochain pas, red flag, mécanisme.

Q1 **EX** **E1 · DX.4** Évaluation / diagnostic · EMS

Un homme de 81 ans, résident d'un EMS, est retrouvé par l'infirmière pâle, couvert de sueurs et confus vers 10 h. Il est diabétique de type 2 sous insuline. Il respire normalement, pouls 96/min, PA 138/82 mmHg. Il n'a pas pris son petit déjeuner.

Quel est le premier geste le plus approprié ?

- **A** ECG 12 dérivations
- **B** Glycémie capillaire immédiate
- **C** Température centrale mesurée
- **D** Hémocultures en deux paires
- **E** Dosage de la TSH sérique

Q2 **EX** **hors liste · SCA** Prise en charge · cabinet

Un homme de 64 ans, diabétique depuis 15 ans, consulte au cabinet pour des sueurs profuses apparues il y a 40 min au repos, avec nausées et « oppression » mal définie, sans douleur thoracique franche. Glycémie capillaire 7,4 mmol/L. PA 150/90 mmHg, pouls 92/min.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Troponine unique, puis retour à domicile si normale
- **B** Anxiolytique et réévaluation dans 1 heure
- **C** Holter ECG de 24 heures en ambulatoire
- **D** Dosage de la TSH et de la fT4
- **E** ECG 12 dérivations interprété dans les 10 minutes

Q3 **AP** **DX.5 vs DX.10** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 34 ans consulte pour une transpiration qui la gêne au travail. Vous cherchez l'élément d'anamnèse qui doit vous faire quitter l'hypothèse d'une hyperhidrose primaire.

Quel élément impose le plus fortement de rechercher une cause secondaire ?

- **A** Début des symptômes à l'âge de 16 ans
- **B** Atteinte palmaire bilatérale et symétrique
- **C** Mère présentant la même sudation
- **D** Gêne pour serrer la main des clients
- **E** Réveils nocturnes avec draps trempés

Q4 **AP** **mécanisme** Mécanismes · urgences

Une femme de 41 ans est vue aux urgences pendant un accès de 15 min : sueurs, céphalée, palpitations. La peau des extrémités est froide et pâle. Pouls 124/min.

Quel mécanisme explique le mieux cet aspect cutané pendant l'accès ?

- **A** Déplacement de la consigne thermique par les cytokines
- **B** Vasodilatation par les amines tumorales
- **C** Décharge sympathique catécholaminergique avec vasoconstriction
- **D** Signalisation NK3 hypothalamique
- **E** Surstimulation focale de glandes eccrines normales

Q5 **EX** **hors liste · coup de chaleur** Prise en charge · autre (chantier)

Un ouvrier de 58 ans travaille sur un chantier pendant une canicule. Il prend de l'oxybutynine. Ses collègues l'amènent car il tient des propos incohérents. La peau est chaude et sèche, sans sueur.

Quelle est la conduite immédiate la plus appropriée ?

- **A** Paracétamol IV puis réévaluation à 1 heure
- **B** Hémocultures puis antibiothérapie empirique
- **C** Hydratation orale et retour au domicile
- **D** Antitranspirant et conseils d'hygiène
- **E** Appel du 144 et refroidissement immédiat

Q6 **EX** **E2 · DX.9** Prise en charge · EMS

Une femme de 79 ans, en EMS, présente depuis la nuit des frissons et des sueurs. Température 39,1 °C (tympanique), confusion nouvelle, FR 24/min, PA 86/50 mmHg malgré 500 mL de cristalloïdes.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Hémocultures, antibiotique dans l'heure, hôpital
- **B** Paracétamol et réévaluation à 48 h
- **C** Antibiotique oral, hémocultures si persistance
- **D** IGRA et radiographie thoracique ambulatoires
- **E** Échocardiographie transthoracique en ambulatoire

Q7 **AP** **DX.4 / DX.8** Mécanismes · cabinet

Une femme de 66 ans, diabétique sous insuline, prend du métoprolol pour une cardiopathie. Elle rapporte des épisodes de malaise avant le repas, avec glycémie capillaire mesurée à 3,2 mmol/L.

Quel signe d'alerte de l'hypoglycémie est le plus atténué par son traitement ?

- **A** La sueur
- **B** La faim
- **C** La confusion
- **D** La vision floue
- **E** La tachycardie

Q8 **EX** **sueurs nocturnes** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 47 ans consulte pour des sueurs nocturnes depuis 6 semaines. Pas de fièvre mesurée, poids stable, pas de toux, aucun nouveau médicament, alcool occasionnel. Examen complet normal, aucune adénopathie.

Quel bilan de première intention est le plus approprié ?

- **A** TEP-TDM corps entier
- **B** Biopsie ganglionnaire
- **C** 5-HIAA urinaire de 24 h
- **D** Métanéphrines libres plasmatiques
- **E** Hémogramme, CRP et TSH

Q9 **EX** **DX.5** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 22 ans consulte pour des paumes et des aisselles moites depuis l'âge de 14 ans, bilatérales, plusieurs fois par semaine, jamais la nuit. Sa mère a le même problème. Elle évite d'écrire au tableau. À l'examen, la peau est sèche.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Retenir une hyperhidrose primaire clinique et grader le HDSS
- **B** Bilan sanguin systématique (TSH, glycémie, hémogramme)
- **C** Test de Minor pour confirmer le diagnostic
- **D** Rassurer : l'examen sec exclut une maladie
- **E** Gravimétrie avec seuil obligatoire

Q10 **AP** **DX.5** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 25 ans présente une hyperhidrose axillaire primaire typique. Avant de choisir le traitement, vous voulez documenter le retentissement initial pour pouvoir juger l'effet à 4 semaines.

Quel outil est le plus approprié ?

- **A** Test de Minor
- **B** Échelle HDSS
- **C** Gravimétrie
- **D** Hémogramme et CRP
- **E** Dosage de la TSH

Q11 **AP** **DX.9 vs coup de chaleur** Mécanismes · autre (chantier)

Un ouvrier de 35 ans s'effondre, confus, après un effort prolongé sur un chantier pendant une canicule. Température rectale 41 °C, peau chaude. Un collègue propose de lui donner du paracétamol.

Quel mécanisme explique que l'antipyrétique soit inefficace dans cette situation ?

- **A** Consigne hypothalamique normale, élimination dépassée
- **B** Consigne relevée par la PGE2 sur le récepteur EP3
- **C** Libération de cytokines pyrogènes (IL-1β, IL-6)
- **D** Vasoconstriction cutanée avec frissons
- **E** Signalisation NK3 hypothalamique désinhibée

Q12 **AP** **DX.1** Mécanismes · cabinet

Une femme de 54 ans, ménopausée depuis 2 ans, présente des bouffées de chaleur modérées à sévères qui fragmentent son sommeil. Elle refuse tout traitement hormonal. Vous prescrivez du fézolinétant (VEOZA™ 45 mg/j).

Quel est le mécanisme d'action de ce médicament ?

- **A** Antagoniste sélectif du récepteur NK3
- **B** Antagoniste des récepteurs NK1 et NK3
- **C** Agoniste des récepteurs aux œstrogènes
- **D** Inhibition sélective de la recapture de la sérotonine
- **E** Antagonisme compétitif des récepteurs muscariniques

Q13 **AP** **DX.5** Mécanismes · cabinet

Un homme de 29 ans souffre d'une hyperhidrose axillaire primaire HDSS 3. Les sels d'aluminium, correctement appliqués le soir sur peau sèche, ont échoué. Vous proposez de la toxine botulique A (BOTOX® 50 U par aisselle, intradermique).

Quel mécanisme explique l'effet de ce traitement ?

- **A** Blocage compétitif des récepteurs muscariniques
- **B** Clivage de SNAP-25, blocage de l'exocytose d'acétylcholine
- **C** Complexation aux mucopolysaccharides, fermeture du canal
- **D** Blocage des récepteurs alpha-adrénergiques glandulaires
- **E** Destruction définitive des glandes eccrines

② Discriminer · 29 Q · un signe, un examen qui tranche

Vignettes du cabinet, des urgences, de l'EMS et de l'hôpital. Les options sont des DX réels du LOT, ou l'examen ou le traitement que le cours retient.

Q14 **EX** **DX.1** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 51 ans consulte pour des accès de chaleur brutale du visage et du haut du corps, suivis d'une sueur profuse, plusieurs fois par jour et la nuit, depuis 8 mois. Cycles irréguliers. Pas de diarrhée, poids stable, température normale, examen normal entre les accès.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Syndrome carcinoïde (tumeur neuroendocrine)
- **B** Hyperthyroïdie par maladie de Basedow
- **C** Phéochromocytome surrénalien
- **D** Symptômes vasomoteurs de la ménopause
- **E** Trouble panique avec agoraphobie

Q15 **AP** **DX.1** Évaluation / diagnostic · cabinet

Même patiente de 51 ans : bouffées humides et cycles irréguliers depuis 8 mois, aucun signe d'alarme. Elle souhaite être soulagée.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Doser FSH et œstradiol avant tout traitement
- **B** 5-HIAA urinaire sur deux collectes de 24 h
- **C** Diagnostic clinique et traitement adapté
- **D** Métanéphrines libres plasmatiques à jeun
- **E** TEP-TDM pour exclure une néoplasie

Q16 **EX** **DX.15** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 63 ans décrit des rougeurs brèves, rouge vif, du visage, du cou et du thorax, sans transpiration, depuis 4 mois, avec 5 selles aqueuses par jour, y compris la nuit, et des épisodes sibilants. Le foie est augmenté de volume et irrégulier.

Quel examen est le plus approprié pour confirmer l'hypothèse principale ?

- **A** Métanéphrines libres plasmatiques
- **B** FSH et œstradiol sériques
- **C** 5-HIAA urinaire de 24 h, deux collectes
- **D** TSH avec fT4 en réflexe
- **E** Hémocultures en deux paires

Q17 **EX** **DX.13** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 44 ans présente 3 à 4 fois par mois des accès de 10–20 min de céphalées violentes, palpitations, sueurs et pâleur. PA mesurée pendant un accès 210/115 mmHg ; entre les accès 128/80 mmHg. Examen normal.

Quel examen est le plus approprié en première intention ?

- **A** Métanéphrines libres plasmatiques
- **B** TDM des surrénales d'emblée
- **C** Scintigraphie à la MIBG
- **D** 5-HIAA urinaire sur 24 heures
- **E** Holter ECG sur 24 heures

Q18 **EX** **DX.2** Évaluation / diagnostic · urgences

Un homme de 27 ans consulte aux urgences pour un 3e épisode en 2 mois : peur intense culminant en 10 min, palpitations, sueurs, sensation d'étouffement, paresthésies, peur de mourir ; résolution en 25 min. Depuis 5 semaines, il évite les transports par crainte d'un nouvel accès. ECG normal, glycémie 5,4 mmol/L, TSH 1,8 mUI/L, PA 128/76 mmHg.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Phéochromocytome
- **B** Trouble panique
- **C** Hyperthyroïdie
- **D** Hypoglycémie
- **E** Syndrome coronarien aigu

Q19 **EX** **DX.7** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 40 ans se plaint de bouffées de chaleur, de nervosité et d'une perte de 5 kg malgré un bon appétit. Cycles réguliers. Pouls 108/min régulier, peau chaude et moite, tremblement fin des mains tendues.

Quel examen est le plus approprié en premier ?

- **A** FSH et œstradiol
- **B** Anticorps anti-récepteur de la TSH d'emblée
- **C** Scintigraphie thyroïdienne
- **D** TSH, avec fT4 et T3 en réflexe si elle est basse
- **E** Métanéphrines libres plasmatiques

Q20 **EX** **DX.6** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 49 ans, opéré d'une fracture de cheville, est hospitalisé depuis 36 h. Il devient agité et anxieux, transpire abondamment, tremble des mains tendues. Pouls 118/min, PA 158/94 mmHg, température 37,4 °C, glycémie 6,1 mmol/L. Son épouse signale 8 verres de vin par jour.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Thyrotoxicose
- **B** Sepsis
- **C** Hypoglycémie
- **D** Trouble panique
- **E** Sevrage alcoolique

Q21 **EX** **DX.6** Prise en charge · hôpital

Même patient de 49 ans en sevrage : CIWA-Ar à 22. Il est orienté, pas d'hallucinations ni de convulsion. Une perfusion de glucose est prévue.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Halopéridol seul à dose sédative
- **B** Propranolol seul pour la tachycardie
- **C** Clométhiazole et sortie le jour même
- **D** Perfusion de glucose, thiamine le lendemain
- **E** Thiamine IV avant le glucose, puis oxazépam

Q22 **EX** **DX.11** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 31 ans, né dans un pays à forte incidence de tuberculose et arrivé en Suisse il y a 2 ans, tousse depuis 7 semaines, a des sueurs nocturnes et a perdu 6 kg. Radiographie : infiltrat apical droit. L'IGRA est négatif.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Exclure la tuberculose vu l'IGRA négatif
- **B** Test cutané tuberculinique
- **C** Deux expectorations : PCR, microscopie, culture
- **D** TEP-TDM thoracique
- **E** Antibiotique de 7 jours puis contrôle

Q23 **EX** **DX.12** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 26 ans présente une adénopathie cervicale de 3 cm, ferme, indolore, persistante depuis 6 semaines, avec sueurs nocturnes abondantes et une perte de poids de 11 % en 5 mois. Pas de foyer infectieux.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Cytoponction à l'aiguille fine
- **B** Biopsie-exérèse ganglionnaire sans délai
- **C** TEP-TDM de dépistage
- **D** Antibiothérapie de 2 semaines puis contrôle
- **E** Surveillance clinique à 3 mois

Q24 **EX** **DX.14** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 67 ans, porteur d'une prothèse valvulaire aortique, présente depuis 3 semaines une fièvre jusqu'à 38,6 °C et des sueurs nocturnes. Il est hémodynamiquement stable. Hémorragies en flammèches sous-unguéales.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Amoxicilline orale empirique
- **B** ETT seule ; si normale, endocardite exclue
- **C** CRP de contrôle dans une semaine
- **D** Trois séries d'hémocultures, puis ETT et ETO
- **E** IGRA et radiographie thoracique

Q25 **SPE · Infectiologie** **DX.14** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 24 ans consulte pour fièvre, sueurs, maux de gorge, adénopathies et éruption cutanée depuis 5 jours. Il rapporte un rapport sexuel non protégé avec un partenaire occasionnel il y a 3 semaines.

Quelle stratégie de test est la plus appropriée ?

- **A** Autotest VIH à domicile
- **B** Test de 4e génération et test moléculaire
- **C** Sérologie anticorps seule dans 3 mois
- **D** Numération des CD4 isolée
- **E** Test de 4e génération seul ; négatif = exclu

Q26 **EX** **DX.8** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 45 ans signale des sueurs diffuses apparues 3 semaines après l'introduction d'escitalopram 10 mg. Cycles réguliers, apyrexie, poids stable. Examen normal, sans clonus ni hyperréflexie. TSH, glycémie, CRP et hémogramme normaux.

Quel est le diagnostic le plus probable ?

- **A** Syndrome sérotoninergique
- **B** Hyperhidrose primaire
- **C** Hyperhidrose médicamenteuse
- **D** Hyperthyroïdie
- **E** Symptômes vasomoteurs de la ménopause

Q27 **EX** **DX.4** Prise en charge · EMS

Un homme de 78 ans, en EMS, sous gliclazide (Diamicron® MR), est retrouvé en sueurs et somnolent. Glycémie 2,4 mmol/L. Il ne déglutit pas de façon sûre. Une voie veineuse est posée.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** Glucose IV et surveillance prolongée
- **B** GlucaGen® 1 mg IM puis surveillance de 2 h
- **C** 15 g de glucides par voie orale
- **D** Glucagon répété toutes les 10 minutes
- **E** Thiamine seule puis contrôle

Q28 **EX** **DX.10** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 62 ans consulte pour une transpiration généralisée apparue il y a 4 mois, y compris la nuit. Aucun antécédent de sudation, aucun nouveau médicament. IMC 25 kg/m². Examen sans particularité.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Chlorure d'aluminium le soir
- **B** Oxybutynine hors indication
- **C** Bilan étiologique ciblé
- **D** Toxine botulique axillaire
- **E** Sympathectomie thoracique

Q29 **EX** **DX.3** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 55 ans, IMC 34 kg/m², tour de cou 45 cm, se réveille trempé plusieurs nuits par semaine. Il ronfle et somnole le jour. Apyrexie, poids stable ; hémogramme, CRP, TSH et glycémie normaux.

Quel examen est le plus approprié ?

- **A** TEP-TDM corps entier
- **B** Métanéphrines libres plasmatiques
- **C** Étude du sommeil (polysomnographie)
- **D** 5-HIAA urinaire de 24 h
- **E** Biopsie ganglionnaire

Q30 **AP** **DX.6** Mécanismes · hôpital

Un homme de 52 ans, buveur quotidien, est hospitalisé pour un sevrage alcoolique : tremblement, sueurs, tachycardie, CIWA-Ar 18. Un interne demande pourquoi on prescrit de l'oxazépam plutôt qu'un autre psychotrope.

Quel mécanisme justifie la benzodiazépine dans le sevrage ?

- **A** Modulation glutamatergique du craving
- **B** Potentialisation du GABA-A, en remplacement de l'éthanol
- **C** Antagonisme des récepteurs opioïdes
- **D** Antagonisme des récepteurs dopaminergiques D2
- **E** Blocage des récepteurs bêta-adrénergiques

Q31 **AP** **DX.3** Mécanismes · cabinet

Un homme de 55 ans, IMC 36 kg/m², ronfle fort ; sa partenaire décrit des pauses respiratoires. Il se réveille trempé plusieurs nuits par semaine. Apyrexie, poids stable, aucun traitement hypoglycémiant ; TSH et hémogramme normaux.

Quel mécanisme explique le mieux ses sueurs nocturnes ?

- **A** Consigne thermique relevée par des cytokines
- **B** Signalisation NK3 hypothalamique désinhibée
- **C** Libération d'amines vasoactives tumorales
- **D** Hypoxie et micro-éveils avec décharge sympathique
- **E** Contre-régulation adrénergique d'une hypoglycémie

Q32 **SPE · Psychiatrie** **DX.2** Prise en charge · cabinet

Un homme de 27 ans, chez qui un trouble panique a été posé (ECG, glycémie et TSH normaux), a débuté de l'escitalopram il y a 10 jours. Il dit que « rien n'a changé » et qu'il transpire un peu plus. Il demande un traitement plus efficace.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Ajouter du lorazépam au long cours
- **B** Arrêter brutalement l'escitalopram
- **C** Poursuivre l'ISRS, réévaluer à 2–6 semaines, associer la TCC
- **D** Ajouter de l'oxybutynine contre la sueur
- **E** Remplacer d'emblée par la venlafaxine

Q33 **SPE · Hématologie** **DX.12** Prise en charge · hôpital

Une femme de 31 ans traitée pour un lymphome de Hodgkin classique termine sa chimiothérapie. Le TEP-TDM de fin de traitement montre une masse médiastinale résiduelle cotée Deauville 4.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Surveillance : réponse métabolique complète
- **B** Biopsie médullaire de contrôle
- **C** Scanner de surveillance tous les 3 mois
- **D** Radiothérapie de site impliqué sur le résidu
- **E** Arrêt du suivi hématologique

Q34 **EX** **DX.2 vs DX.4** Évaluation / diagnostic · urgences

Une femme de 34 ans arrive aux urgences pour un premier épisode de sueurs profuses, palpitations et peur de mourir, survenu au supermarché il y a 30 minutes. Elle n'a aucun antécédent. Elle est encore anxieuse et moite.

Quelle est la conduite initiale la plus appropriée ?

- **A** ECG, glycémie capillaire, signes vitaux et TSH avant de retenir un trouble anxieux
- **B** Retenir un trouble panique et débuter l'escitalopram
- **C** Lorazépam au long cours
- **D** Questionnaire d'anxiété : un score ≥ 10 confirme le diagnostic
- **E** Rassurer et renvoyer sans examen

Q35 **EX** **DX.3 vs DX.4** Prise en charge · cabinet

Un homme de 57 ans, IMC 36 kg/m², diabétique de type 2 sous insuline basale, va débuter un agoniste du GLP-1 pour son poids. Il signale déjà des sueurs en fin de matinée.

Quelle mesure associer au début du traitement ?

- **A** Augmenter l'insuline pour compenser la baisse d'appétit
- **B** Réduire la dose d'insuline et renforcer l'autosurveillance glycémique
- **C** Aucune mesure : l'agoniste du GLP-1 ne modifie pas le risque d'hypoglycémie sous insuline
- **D** Arrêter l'insuline définitivement
- **E** Prescrire un bêtabloquant contre les sueurs

Q36 **EX** **DX.5** Prise en charge · cabinet

Une étudiante de 21 ans a une hyperhidrose axillaire primaire typique (4 critères sur 7, depuis l'âge de 13 ans, jamais la nuit), HDSS 3. Aucun traitement antérieur.

Quel est le traitement de première ligne le plus approprié ?

- **A** Sympathectomie thoracique
- **B** Oxybutynine orale
- **C** Sels d'aluminium (10–30 %) appliqués le soir sur peau sèche
- **D** Bilan sanguin systématique avant tout traitement
- **E** Toxine botulique d'emblée

Q37 **EX** **DX.8 vs DX.2** Prise en charge · cabinet

Un homme de 45 ans a arrêté de lui-même son escitalopram il y a 4 jours. Depuis, il transpire beaucoup, a des vertiges et se sent irritable.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Diagnostiquer une rechute anxieuse et doubler la dose
- **B** Prescrire une benzodiazépine au long cours
- **C** Rassurer sans rien changer si les symptômes sont invalidants
- **D** Reprendre la dose antérieure puis décroître plus lentement, sur au moins 1 à 2 semaines
- **E** Doser la TSH et attendre

Q38 **EX** **DX.9** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 39 ans consulte pour fièvre à 39,2 °C, frissons et sueurs depuis 2 jours. Il est rentré il y a 10 jours d'un séjour au Cameroun ; il a pris sa prophylaxie antipaludique correctement.

Quel examen est le plus urgent ?

- **A** Aucun : la prophylaxie exclut le paludisme
- **B** Sérologie de la dengue dans 2 semaines
- **C** Procalcitonine pour décider d'un antibiotique
- **D** Paracétamol et contrôle dans 1 semaine
- **E** Recherche de paludisme le jour même

Q39 **EX** **DX.10 vs DX.5** Prise en charge · cabinet

Un homme de 48 ans consulte pour une transpiration apparue il y a 3 mois, limitée à l'hémicorps gauche, y compris la nuit. Il demande « un traitement contre la transpiration ».

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Chercher une cause secondaire avant tout traitement symptomatique
- **B** Sels d'aluminium et réévaluation à 3 mois
- **C** Toxine botulique sur la zone
- **D** Oxybutynine orale hors indication
- **E** Retenir une hyperhidrose primaire selon Walling

Q40 **EX** **DX.11** Prise en charge · cabinet de pédiatrie

La mère d'un enfant de 3 ans vient d'apprendre que le grand-père, qui vit avec eux, a une tuberculose pulmonaire contagieuse confirmée. L'enfant va bien.

Quand faut-il tester l'enfant ?

- **A** 2 mois après la dernière exposition
- **B** Sans délai
- **C** Seulement s'il devient symptomatique
- **D** À 6 mois
- **E** Jamais avant l'âge de 5 ans

Q41 **EX** **DX.12 vs DX.1** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 52 ans a des sueurs nocturnes isolées depuis 6 semaines. Pas de fièvre mesurée, pas de perte de poids, aucun ganglion palpable, rate non palpable.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Biopsie ganglionnaire
- **B** TEP-TDM de dépistage du lymphome
- **C** Chercher ménopause, médicaments, thyroïde et apnées, traiter 4 à 8 semaines puis réévaluer
- **D** Biopsie médullaire
- **E** Conclure d'emblée au lymphome

Q42 **EX** **DX.15** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 64 ans a un syndrome carcinoïde confirmé (5-HIAA urinaire élevé, métastases hépatiques). Il n'a aucun souffle cardiaque.

Quel examen faut-il réaliser ?

- **A** Aucun : l'absence de souffle exclut la cardiopathie
- **B** Coronarographie
- **C** ECG d'effort
- **D** NT-proBNP et échocardiographie à la recherche d'une cardiopathie carcinoïde
- **E** Dosage des métanéphrines

🚩 Pièges & alarmes · 9 Q · ce qu'il ne faut jamais rater

Glucagon, bêtabloquant seul, thiamine, faux positifs, ETT rassurante à tort, « c'est la ménopause ».

Q43 **EX** **DX.13 × DX.4** Prise en charge · urgences

Une femme de 52 ans, diabétique sous insuline, en cours de bilan pour un phéochromocytome (métanéphrines à 3 fois la limite), est amenée inconsciente. Glycémie 1,9 mmol/L. Une voie veineuse est en place.

Quel traitement est le plus approprié ?

- **A** GlucaGen® 1 mg IM
- **B** Glucose IV
- **C** Glucagon nasal 3 mg
- **D** 15 g de glucides par voie orale
- **E** Thiamine seule

Q44 **SPE · Endocrinologie** **DX.13** Prise en charge · hôpital

Un homme de 46 ans a un phéochromocytome confirmé et localisé ; l'opération est prévue dans 3 semaines. Il présente encore des accès hypertensifs avec tachycardie.

Quelle préparation médicamenteuse est la plus appropriée ?

- **A** Propranolol seul
- **B** Métoclopramide en cas de nausées
- **C** Aucun traitement jusqu'à l'opération
- **D** Test au glucagon avant l'opération
- **E** Alpha-bloquant, puis bêtabloquant si besoin

Q45 **EX** **DX.6 × DX.4** Prise en charge · urgences

Un homme de 57 ans, alcoolique chronique dénutri, est trouvé confus et en sueurs après 2 jours sans manger. Glycémie 2,6 mmol/L. Voie veineuse en place.

Quelle conduite est la plus appropriée ?

- **A** Glucose IV sans délai, en associant la thiamine
- **B** GlucaGen® 1 mg IM
- **C** Thiamine d'abord, glucose 1 heure plus tard
- **D** Oxazépam puis glycémie de contrôle
- **E** 15 g de glucides oraux

Q46 **SPE · Oncologie (TNE)** **DX.15** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 58 ans sous sertraline et paracétamol au long cours décrit des rougeurs du visage peu typiques. Le 5-HIAA urinaire de 24 h revient à 62 µmol/24 h. Elle n'a ni diarrhée ni sibilances, foie normal.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Retenir un syndrome carcinoïde et débuter l'octréotide
- **B** TEP-TDM pour localiser la tumeur
- **C** Doser les métanéphrines plasmatiques
- **D** Nouveau dosage après éviction encadrée
- **E** Classer comme bouffées ménopausiques

Q47 **SPE · Cardiologie** **DX.14** Évaluation / diagnostic · hôpital

Un homme de 70 ans, porteur d'une prothèse mitrale, a 3 hémocultures positives à Staphylococcus aureus, de la fièvre et des sueurs nocturnes. L'ETT ne montre pas de végétation ; aucun souffle nouveau.

Quelle est la prochaine étape la plus appropriée ?

- **A** Conclure à une bactériémie sans endocardite
- **B** Répéter l'ETT dans 3 mois
- **C** TEP-TDM de dépistage d'un cancer
- **D** Échocardiographie transœsophagienne
- **E** IGRA

Q48 **EX** **DX.1 × DX.10** Évaluation / diagnostic · cabinet

Une femme de 52 ans, en périménopause, consulte pour des sueurs nocturnes depuis 2 mois. Elle a mesuré à plusieurs reprises 38,3 °C le soir et a perdu 7 % de son poids sans le vouloir.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Recherche d'une infection et d'un lymphome
- **B** Traitement hormonal de la ménopause
- **C** Fézolinétant 45 mg/j
- **D** Thérapie cognitivo-comportementale
- **E** Oxybutynine hors indication

Q49 SPE · Dermatologie DX.5 Prise en charge · cabinet question négative

Un homme de 23 ans présente une hyperhidrose axillaire primaire typique, HDSS 3. Il n'a jamais été traité.

Laquelle des propositions suivantes est INAPPROPRIÉE ?

A Chlorure d'aluminium 10–30 % le soir sur peau sèche

B Éviction des épices, de l'alcool et du café

C Glycopyrronium topique en cas d'échec

D Sympathectomie thoracique en première intention

E Toxine botulique A en cas d'échec

Q50 EX DX.7 Prise en charge · cabinet

Une femme de 38 ans traitée par carbimazole depuis 5 semaines pour une maladie de Basedow appelle un vendredi soir : fièvre à 38,9 °C et mal de gorge depuis ce matin.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

A Poursuivre et revoir lundi

B Amoxicilline et poursuite du carbimazole

C Doubler le propranolol

D Remplacer d'emblée par l'iode radioactif

E Arrêter le carbimazole et faire un hémogramme immédiatement

Q51 **EX** **DX.14** Évaluation / diagnostic · cabinet

Un homme de 30 ans a eu un rapport à risque il y a 3 semaines. Il a de la fièvre, des sueurs et une angine. Le test VIH de 4e génération est négatif.

Quelle est la conduite la plus appropriée ?

- **A** Ajouter un test moléculaire du VIH (ARN)
- **B** Exclure le VIH sur ce test
- **C** Faire un test rapide pour confirmer
- **D** Attendre 3 mois avant tout nouveau test
- **E** Conclure à une angine virale banale

⇢ Algorithme condensé · si… alors…

Si…	Alors…
Malaise, confusion, oppression, dyspnée, chaleur avec trouble neurologique	Fonctions vitales + glycémie ; ECG en 10 min ; 144 et refroidir si coup de chaleur
E1 · Diabétique sous insuline/sulfonylurée, glycémie < 4,0 mmol/L	Corriger selon la conscience : 15 g (30 g si < 2,5) per os ; GlucaGen® 1 mg sous insuline seulement ; glucose IV sous sulfonylurée (surveillance ≥ 48 h)
E2 · Fièvre avec défaillance	Hémocultures avant antibiotique (< 30 min si choc), hospitalisation
E3 · Fièvre prolongée + prothèse, souffle nouveau, drogues IV ; risque VIH	3 séries d'hémocultures, ETT puis ETO ; test VIH ≥ 4e génération (+ moléculaire si primo-infection)
E4 · Dernier verre il y a 6–72 h, tremblement, sueurs	CIWA-Ar ; thiamine avant tout glucose ; oxazépam selon la sévérité ; hôpital si ≥ 20, convulsion, delirium
E5 · Thermophobie, tachycardie, amaigrissement	TSH → fT4/T3 en réflexe ; propranolol ; endocrinologie
E6 · Accès céphalée + palpitations + sueurs + pâleur	Métanéphrines libres (couché ≥ 20 min) ; ni glucagon ni bêtabloquant seul

E7 · Toux, exposition, sueurs nocturnes	2 expectorations (PCR, culture) ; précautions de transmission ; IGRA négatif ne clôt rien
E8 · Adénopathie > 4–6 sem ou splénomégalie + symptômes B	Biopsie-exérèse (pas d'aiguille fine)
E9 · Flush sec + diarrhée ou sibilances	5-HIAA urinaire 24 h ×2 après éviction ; centre spécialisé
Bouffées humides, cycles irréguliers, ≥ 45 ans	DX.1 : diagnostic clinique, sans dosage hormonal
Accès de peur ≥ 4 symptômes, examen normal entre les accès	DX.2 : DSM-5 après TSH, glycémie, ECG ; TCC et/ou ISRS
Médicament inducteur introduit ou augmenté	DX.8 : arrêt ou substitution avec le prescripteur (décroissance progressive)
Focale, bilatérale, depuis l'adolescence, jamais la nuit, ≥ 4/7	DX.5 : HDSS ; aluminium → glycopyrronium topique ou toxine
Sueurs à l'effort ou nocturnes, IMC ≥ 30, ronflements	DX.3 : perte de poids ; étude du sommeil
Généralisée, asymétrique ou nocturne, sans orientation	DX.10 : électrolytes, créatinine, glycémie, TSH, hémogramme, CRP ; IGRA, VIH, radiographie ; suivi si négatif, sans TEP de dépistage

Source : Phase A · Algorithme discriminant et §10 Arbre décisionnel.

✅ Corrigé commenté · à consulter après avoir répondu

Q1 **EX** **E1 · DX.4**

✅ **B** — Glycémie capillaire immédiate

① **Pourquoi c'est juste** Pâleur + sueur + confusion chez un diabétique sous insuline = hypoglycémie jusqu'à preuve du contraire (E1). La glycémie capillaire tranche et se corrige en minutes.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Utile ensuite si oppression ou glycémie normale ; ne précède pas une glycémie corrigible en minutes.
- **C** Pertinente, mais la confusion sudorale du diabétique traité impose d'abord le glucose.
- **D** Réservées à la fièvre avec défaillance (E2) ; aucun argument infectieux ici.
- **E** Thyrotoxicose = E5 ; jamais avant d'avoir écarté l'hypoglycémie (E1).

③ **Perle** Si la mesure est impossible, traiter sans attendre le résultat. Une glycémie normale ne clôt rien : penser cœur, infection, toxique, chaleur.

④ **Source** Phase A §10 Arbre, nœuds 0 et 3 · LOT_001 audité

Q2 **EX** **hors liste · SCA**

✅ **E** — ECG 12 dérivations interprété dans les 10 minutes

① **Pourquoi c'est juste** La sueur peut être le seul signe d'ischémie, surtout chez le diabétique âgé. Oppression/dyspnée + sueur = filière coronarienne, ECG en 10 min (hors liste, avant E1).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Une première troponine normale ne rassure pas ; l'ECG passe avant.
- **B** Attribuer la sueur à l'anxiété fait manquer l'ischémie.
- **C** Délai incompatible avec un SCA possible.
- **D** Ne répond pas à l'urgence coronarienne.

③ **Perle** Sus-décalage persistant : reperfusion sans attendre la troponine ; jamais de retour seul.

④ **Source** Phase A §4 Démarche, drapeaux rouges · LOT_001 audité

Q3 AP DX.5 vs DX.10

✅ **E** — Réveils nocturnes avec draps trempés

① **Pourquoi c'est juste** La forme primaire cesse pendant le sommeil ; l'absence de sueur nocturne est un des 7 critères. Une nuit mouillée oriente vers fièvre, ménopause, tumeur (OR 23,2).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Début ≤ 25 ans = critère de forme primaire.
- **B** Profil focal symétrique typique du primaire.
- **C** Agrégation familiale (30–65 %) : critère primaire.
- **D** Retentissement fonctionnel : critère primaire, pas un signe secondaire.

③ **Perle** Nocturne, généralisée, asymétrique ou début > 25 ans → bilan secondaire.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_001 audité

Q4 AP mécanisme

✅ **C** — Décharge sympathique catécholaminergique avec vasoconstriction

① **Pourquoi c'est juste** Pendant un accès, peau froide et pâle = décharge sympathique (phéochromocytome, panique) ; peau chaude et rouge = vasodilatation (ménopause, carcinoïde).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Mécanisme de la fièvre : peau chaude, frissons.
- **B** Flush carcinoïde : peau rouge, sèche.
- **D** Bouffée ménopausique : peau chaude et rouge, humide.
- **E** Hyperhidrose primaire : focale, sans pâleur ni tachycardie.

③ **Perle** Triade céphalée-palpitations-sueurs + pâleur : métanéphrines, pas d'étiquette « panique » d'emblée.

④ **Source** Phase A §6 Examen physique · LOT_001 audité

Q5 **EX** hors liste · coup de chaleur

✅ **E** — Appel du 144 et refroidissement immédiat

① **Pourquoi c'est juste** Sans sueur, la température centrale monte sans frein (anhidrose, ici aggravée par un anticholinergique). Chaleur + trouble neurologique = 144 et refroidissement.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Les antipyrétiques ne corrigent pas l'hyperthermie du coup de chaleur.
- **B** Retarde le refroidissement ; le contexte est thermique.
- **C** Confusion = trouble neurologique : urgence vitale.
- **D** Jamais d'antitranspirant sur une peau qui ne transpire plus.

③ **Perle** L'absence de sueur à la chaleur n'est jamais rassurante. Cible Suva : < 40 °C en 30 min.

④ **Source** Phase A §11 Urgences hors liste · LOT_001 audité

Q6 **EX** E2 · DX.9

✅ **A** — Hémocultures, antibiotique dans l'heure, hôpital

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre + défaillance (confusion, hypotension, FR ≥ 22) = E2. Prélever avant l'antibiotique (en < 30 min si choc), antibiotique dans l'heure, hospitaliser.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Un antipyrétique normalise la température sans fermer l'hypothèse ; défaillance présente.
- **C** Prélever avant de traiter ; voie orale inadaptée au choc.
- **D** Hors sujet devant un choc.
- **E** N'est pas l'étape immédiate d'une défaillance.

③ **Perle** Le qSOFA ne sert jamais seul à exclure un sepsis.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_001 audité

Q7 AP DX.4 / DX.8

✅ **E** — La tachycardie

① **Pourquoi c'est juste** Le bêtabloquant masque la tachycardie (et prolonge l'hypoglycémie sous insuline) ; la sueur, cholinergique, persiste : elle devient le signal clé.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Commande cholinergique : non inhibée, parfois renforcée sous bêtabloquant.
- **B** Signe non masqué par le bêtablocage.
- **C** Signe neuroglycopénique, non masqué.
- **D** Signe neuroglycopénique, non masqué.

③ **Perle** AIPS Inderal® : « ne doit pas être utilisé chez les patients qui ont tendance à faire des hypoglycémies ».

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_001 audité

Q8 EX sueurs nocturnes

✅ **E** — Hémogramme, CRP et TSH

① **Pourquoi c'est juste** Sueurs nocturnes inexpliquées : hémogramme, CRP, TSH ; IGRA + radiographie si tuberculose plausible ; test VIH 4e génération selon le risque.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Jamais en dépistage ; réservé à la stadification d'un lymphome prouvé.
- **B** Aucune adénopathie : pas de cible.
- **C** Réservé au flush sec avec diarrhée ou sibilances.
- **D** Réservées aux accès adrénergiques.

③ **Perle** Bilan négatif et stable : suivi programmé ; la disparition des sueurs ne ferme jamais une branche dangereuse.

④ **Source** Phase A §9.b Première intention · LOT_001 audité

Q9 EX DX.5

✅ **A** — Retenir une hyperhidrose primaire clinique et grader le HDSS

① **Pourquoi c'est juste** Sudation focale > 6 mois avec ≥ 4/7 critères suisses (ici bilatérale, ≥ 1/sem, pas nocturne, début ≤ 25 ans, famille, gêne) : diagnostic clinique (Se 99 %, Sp 82 %).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Tableau typique : aucun examen de routine (S1).
- **C** Le Minor cartographie un territoire, il ne pose pas le diagnostic.
- **D** La sueur survient par épisodes ; l'histoire prime.
- **E** Aucun seuil universel ; l'exiger est une erreur.

③ **Perle** Le HDSS initial fixe la cible ; réévaluer à 4 semaines.

④ **Source** Phase A §8 Diagnostic positif · LOT_001 audité

Q10 AP DX.5

✅ **B** — Échelle HDSS

① **Pourquoi c'est juste** Le HDSS (1–4) mesure l'interférence avec les activités : 3–4 = forme sévère. C'est la cible du traitement.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Cartographie la zone active, sans mesurer la gêne.
- **C** Quantifie le débit, très variable, sans référence admise.
- **D** Sans intérêt dans une forme primaire typique.
- **E** Pas d'indication devant un tableau primaire typique.

③ **Perle** Minor = où ; gravimétrie = combien ; HDSS = à quel point ça gêne.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_001 audité

Q11 **AP** **DX.9 vs coup de chaleur**

✅ **A** — Consigne hypothalamique normale, élimination dépassée

① **Pourquoi c'est juste** Dans l'hyperthermie (coup de chaleur, effort, médicament), la consigne reste normale et la production de chaleur dépasse l'élimination. L'antipyrétique, qui abaisse une consigne relevée (PGE2–EP3), n'a donc pas de cible.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** C'est la fièvre infectieuse : c'est précisément là que l'antipyrétique agit.
- **C** Amorce de la fièvre ; absente dans l'hyperthermie d'effort.
- **D** Phase de montée de la fièvre (peau froide), pas l'hyperthermie.
- **E** Mécanisme des bouffées de la ménopause.

③ **Perle** Traiter un coup de chaleur comme une fièvre infectieuse = piège mortel : 144 et refroidissement, cible Suva < 40 °C en 30 min.

④ **Source** Phase B DX.9 §6 · LOT_001 audité

Q12 **AP** **DX.1**

✅ **A** — Antagoniste sélectif du récepteur NK3

① **Pourquoi c'est juste** La chute des œstrogènes désinhibe les neurones KNDy ; la neurokinine B les active via NK3 et la zone thermoneutre se rétrécit → bouffée. Le fézolinétant bloque NK3 (affinité 450× > NK1/NK2) et module le centre thermorégulateur.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** C'est l'élinzanétant (LYNKUET®), autre molécule de la même famille.
- **C** Mécanisme du THM ; le fézolinétant est non hormonal.
- **D** Mécanisme des ISRS, qui peuvent eux-mêmes faire transpirer.
- **E** Mécanisme du glycopyrronium (hyperhidrose focale).

③ **Perle** Bilan hépatique avant, puis chaque mois pendant 3 mois ; ictère, urines foncées ou fatigue → arrêt immédiat et ALAT/ASAT/bilirubine.

④ **Source** Phase B DX.1 §6 · LOT_001 audité

Q13 AP DX.5

✅ **B** — Clivage de SNAP-25, blocage de l'exocytose d'acétylcholine

① **Pourquoi c'est juste** Les glandes eccrines sont normales mais surstimulées : le défaut est dans la commande cholinergique. La toxine clive SNAP-25 (complexe SNARE) et empêche la libération d'acétylcholine à la jonction nerf–glande.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Mécanisme du glycopyrronium crème (Axhidrox®).
- **C** Mécanisme des sels d'aluminium.
- **D** La glande eccrine reçoit une innervation sympathique cholinergique, pas adrénergique.
- **E** C'est l'objectif de la thermolyse ou du curetage ; la toxine n'abîme pas la glande.

③ **Perle** Unités non interchangeables entre toxines ; pas de réinjection avant 16 semaines (BOTOX®).

④ **Source** Phase B DX.5 §6 · LOT_001 audité

Q14 EX DX.1

✅ **D** — Symptômes vasomoteurs de la ménopause

① **Pourquoi c'est juste** Bouffée « humide » (chaleur puis sueur) + cycles modifiés après 45 ans, sans signe général = symptômes vasomoteurs.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Flush sec, avec diarrhée aqueuse ou sibilances.
- **B** Thermophobie, amaigrissement, tachycardie de repos absents.
- **C** Accès avec pâleur, céphalée, palpitations, HTA.
- **E** Accès de peur intense avec ≥ 4 symptômes, non décrit.

③ **Perle** Humide = ménopause ; sec = carcinoïde ; froid et pâle = phéochromocytome ou panique.

④ **Source** Phase A Algorithme, étape 10 · LOT_001 audité

Q15 AP DX.1

✅ **C** — Diagnostic clinique et traitement adapté

① **Pourquoi c'est juste** Après 45 ans, un tableau vasomoteur typique se diagnostique cliniquement (ESE 2025, NICE). Options : information, TCC, THM individualisé ou fézolinétant.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Après 45 ans, le tableau typique suffit ; une FSH normale n'exclut pas.
- **B** Pas de flush sec ni de diarrhée.
- **D** Pas d'accès adrénergique.
- **E** Jamais en dépistage.

③ **Perle** Utérus intact sous œstrogène → progestatif ; voie transdermique = moins de thrombose.

④ **Source** Phase B DX.1 §13 · LOT_001 audité

Q16 EX DX.15

✅ **C** — 5-HIAA urinaire de 24 h, deux collectes

① **Pourquoi c'est juste** Flush sec + diarrhée sécrétoire + sibilances + foie métastatique = syndrome carcinoïde (E9). 5-HIAA > 50 µmol/24 h compatible.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Cherchent un phéochromocytome : accès pâles, hypertensifs.
- **B** Bouffée ménopausique humide, sans diarrhée.
- **D** N'explique pas flush sec + diarrhée sécrétoire + sibilances.
- **E** Aucun tableau fébrile.

③ **Perle** Le syndrome carcinoïde d'une TNE du grêle exige en général des métastases hépatiques (le foie inactive les amines).

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_001 audité

Q17 EX DX.13

✅ **A** — Métanéphrines libres plasmatiques

① **Pourquoi c'est juste** Accès adrénergiques avec pâleur et HTA paroxystique = phéochromocytome (E6). Métanéphrines libres, couchée ≥ 20 min, à jeun (Se 99 %) ; > 2× la limite sur prélèvement correct → localisation.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** L'imagerie localise après la preuve biologique.
- **C** Imagerie fonctionnelle de seconde ligne, moins sensible.
- **D** Pour le flush sec carcinoïde.
- **E** N'explore pas la décharge catécholaminergique.

③ **Perle** Pression normale entre les accès n'exclut rien ; assise et non à jeun, la spécificité chute à 71 %.

④ **Source** Phase B DX.13 §9 · LOT_001 audité

Q18 EX DX.2

✅ **B** — Trouble panique

① **Pourquoi c'est juste** Attaques récurrentes, inattendues, ≥ 4/13 symptômes, acmé en minutes, + ≥ 1 mois de crainte/évitement, imitateurs exclus (ECG, glycémie, TSH) = trouble panique (DSM-5).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas de pâleur, d'HTA ni de céphalée par accès.
- **C** TSH normale : l'écarte presque toujours.
- **D** Glycémie normale, pas de traitement à risque.
- **E** ECG normal, terrain et récurrence non évocateurs.

③ **Perle** Une attaque isolée (1 personne sur 5) ne suffit pas. Traitement : TCC et/ou ISRS.

④ **Source** Phase A §8 Critères DSM-5 · LOT_001 audité

Q19 EX DX.7

✅ **D** — TSH, avec fT4 et T3 en réflexe si elle est basse

① **Pourquoi c'est juste** Thermophobie, amaigrissement malgré l'appétit, tachycardie, tremblement fin = thyrotoxicose (E5). Test réflexe suisse : TSH d'abord.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Cycles réguliers ; le tableau est thyrotoxique, pas ménopausique.
- **B** Établissent la cause (Basedow) après la preuve biologique.
- **C** Pas en première intention ; réservée à la nodularité.
- **E** Pas d'accès paroxystiques avec pâleur.

③ **Perle** Une TSH normale écarte presque toujours l'hyperthyroïdie. Ne jamais conclure « ménopause » avant la TSH.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_001 audité

Q20 EX DX.6

✅ **E** — Sevrage alcoolique

① **Pourquoi c'est juste** Tremblement + sueurs + tachycardie 6–72 h après le dernier verre = sevrage (E4). Pic vers 72 h ; convulsions 12–48 h, delirium 48–72 h.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas de thermophobie ni d'amaigrissement ; le contexte (arrêt brutal d'alcool) prime.
- **B** Apyrexie, pas de foyer ni de défaillance.
- **C** Glycémie normale.
- **D** Diagnostic d'exclusion ; ici une cause somatique évidente.

③ **Perle** Toujours dater le dernier verre et coter le CIWA-Ar.

④ **Source** Phase A §7.6 Sevrage alcoolique · LOT_001 audité

Q21 EX DX.6

✅ **E** — Thiamine IV avant le glucose, puis oxazépam

① **Pourquoi c'est juste** CIWA-Ar ≥ 20 = sevrage sévère : benzodiazépine en premier choix (oxazépam 15–30 mg 3–4×/j, AIPS) ; thiamine avant tout glucose.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** N'agit pas sur l'hyperactivité autonome, abaisse le seuil épileptogène.
- **B** Hors schéma du cours : la benzodiazépine est le premier choix (CBIP).
- **C** Réservé au milieu hospitalier contrôlé ; sortie inadaptée.
- **D** Glucose sans thiamine : risque de Wernicke.

③ **Perle** Jamais d'antipsychotique seul dans le sevrage.

④ **Source** Phase B DX.6 §13 · LOT_001 audité

Q22 EX DX.11

✅ **C** — Deux expectorations : PCR, microscopie, culture

① **Pourquoi c'est juste** Toux persistante + sueurs nocturnes + amaigrissement + origine à risque = tuberculose (E7). La preuve est microbiologique ; précautions de transmission d'emblée.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** > 20 % des tuberculeux ont un IGRA négatif.
- **B** Comme l'IGRA, ne distingue pas infection et maladie.
- **D** N'apporte pas la preuve microbiologique.
- **E** Retarde le diagnostic et la protection des contacts.

③ **Perle** L'IGRA ne confirme ni n'exclut une tuberculose active.

④ **Source** Phase B DX.11 §14 · LOT_001 audité

Q23 EX DX.12

✅ **B** — Biopsie-exérèse ganglionnaire sans délai

① **Pourquoi c'est juste** Adénopathie persistante > 4–6 semaines + symptômes B (sueurs nocturnes, perte > 10 % en 6 mois) = lymphome à prouver (E8) : seule l'histologie tranche.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Ne rend pas l'architecture : insuffisante.
- **C** Sert à la stadification, après l'histologie.
- **D** Retarde le diagnostic d'un ganglion déjà persistant.
- **E** Inadaptée : ganglion > 4–6 sem avec symptômes B.

③ **Perle** Des sueurs nocturnes isolées, sans ganglion ni perte de poids, ne justifient pas de biopsie.

④ **Source** Phase B DX.12 §13 · LOT_001 audité

Q24 EX DX.14

✅ **D** — Trois séries d'hémocultures, puis ETT et ETO

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre prolongée + prothèse + lésions emboliques = endocardite (E3). Trois séries d'hémocultures espacées de 30 min, sans attendre le pic, puis ETT et ETO.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'antibiotique préalable est la 1re cause d'hémocultures négatives.
- **B** Une ETT normale n'exclut pas, surtout sur prothèse.
- **C** Retard d'une infection endovasculaire grave.
- **E** N'explorent pas l'endocardite.

③ **Perle** Absence de souffle ou ETT normale n'exclut jamais : ETO, répétée à 5–7 jours si suspicion forte.

④ **Source** Phase B DX.14 §13 · LOT_001 audité

Q25 SPE · Infectiologie DX.14

✅ **B** — Test de 4e génération et test moléculaire

① **Pourquoi c'est juste** Primo-infection symptomatique : test ≥ 4e génération (Ac + p24) et test moléculaire en parallèle ; tout test réactif se confirme.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un autotest réactif ne suffit pas et la fenêtre est trop précoce.
- **C** Retarde un diagnostic de primo-infection symptomatique.
- **D** Ne pose pas le diagnostic.
- **E** Fenêtre de 6 semaines : un test précoce négatif n'exclut pas.

③ **Perle** ART pour tous, dès le diagnostic, quel que soit le taux de CD4.

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_001 audité

Q26 EX DX.8

✅ **C** — Hyperhidrose médicamenteuse

① **Pourquoi c'est juste** Sueurs apparues avec un ISRS, autres causes exclues (TSH, glycémie, CRP, numération) = cause médicamenteuse. Conduite : arrêt ou substitution avec le prescripteur.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Exige clonus ou hyperréflexie (critères de Hunter) ; la sueur seule ne suffit pas.
- **B** Début tardif, diffus, lié à un médicament.
- **D** TSH normale.
- **E** Cycles réguliers, chronologie médicamenteuse nette.

③ **Perle** Ne jamais stopper brutalement un ISRS : décroissance sur ≥ 1–2 semaines (sinon sueur de sevrage).

④ **Source** Phase B DX.8 §13 · LOT_001 audité

Q27 EX DX.4

✅ **A** — Glucose IV et surveillance prolongée

① **Pourquoi c'est juste** Sulfonylurée + troubles de conscience + voie IV : glucose IV (HUG : 32 g de glucose 40 % lent ; IP : 50 mL 20–30 %) puis glucose 10 % ; surveillance ≥ 48 h car l'hypoglycémie récidive.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Sous sulfonylurée, le glucose IV est le choix ; surveillance trop courte.
- **C** Déglutition non sûre : aucune voie orale.
- **D** Répéter sans glucose IV retarde la correction.
- **E** Ne corrige pas l'hypoglycémie.

③ **Perle** GlucaGen® = surtout sous insuline ; sous sulfonylurée = glucose IV et surveillance prolongée.

④ **Source** Phase A §11 Urgence hypoglycémie · LOT_001 audité

Q28 EX DX.10

✅ **C** — Bilan étiologique ciblé

① **Pourquoi c'est juste** Généralisée, nocturne, début > 25 ans = hyperhidrose secondaire : bilan avant tout traitement symptomatique — électrolytes, créatinine, glycémie, TSH, hémogramme, CRP ; si nocturne, IGRA, VIH, radiographie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Traitement de la forme primaire focale ; masque une cause.
- **B** Aucun anticholinergique qui masquerait des signes généraux.
- **D** Écarter une hyperhidrose secondaire avant (AIPS BOTOX®).
- **E** Réservée aux formes focales primaires rebelles.

③ **Perle** Bilan négatif : suivi programmé, sans TEP-TDM de dépistage.

④ **Source** Phase B DX.10 §13 · LOT_001 audité

Q29 EX DX.3

✅ **C** — Étude du sommeil (polysomnographie)

① **Pourquoi c'est juste** Sueurs nocturnes + IMC ≥ 30 + tour de cou > 43 cm + ronflements/somnolence = apnées du sommeil à documenter.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Pas de dépistage indifférencié.
- **B** Pas d'accès adrénergiques.
- **D** Pas de flush ni de diarrhée.
- **E** Aucune adénopathie.

③ **Perle** La pression positive continue ramène ces sueurs au niveau de la population.

④ **Source** Phase B DX.3 §13 · LOT_001 audité

Q30 AP DX.6

✅ **B** — Potentialisation du GABA-A, en remplacement de l'éthanol

① **Pourquoi c'est juste** L'alcool chronique diminue les récepteurs GABA-A et augmente les NMDA. À l'arrêt, perte du frein GABA + excès de glutamate et de catécholamines → hyperactivité autonome (sueur, tachycardie, tremblement), convulsions 12–48 h, delirium 48–72 h. La benzodiazépine rétablit l'inhibition GABA-A.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Acamprosate : maintien de l'abstinence, pas traitement du sevrage aigu.
- **C** Naltrexone ou nalméfène : réduction de la consommation.
- **D** Halopéridol : n'agit pas sur l'hyperactivité autonome et abaisse le seuil épileptogène.
- **E** Masque la tachycardie sans prévenir convulsions ni delirium.

③ **Perle** Les catécholamines du sevrage font entrer le potassium dans les cellules (hypokaliémie) et l'alcool allonge le QT : surveiller K^+ et ECG.

④ **Source** Phase B DX.6 §6 · LOT_001 audité

Q31 AP DX.3

✅ **D** — Hypoxie et micro-éveils avec décharge sympathique

① **Pourquoi c'est juste** Collapsus pharyngé → apnée → hypoxie et micro-éveil → décharge sympathique → stimulation des glandes eccrines → sueurs nocturnes.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Mécanisme de la fièvre ; apyrexie ici.
- **B** Mécanisme de la bouffée ménopausique.
- **C** Flush carcinoïde sec, avec diarrhée ou sibilances.
- **E** Exige un traitement hypoglycémiant (insuline, sulfonylurée).

③ **Perle** Sueurs nocturnes fréquentes chez 33,2 % des apnéiques non traités, 11,5 % sous pression positive (niveau de la population).

④ **Source** Phase B DX.3 §6 · LOT_001 audité

Q32 SPE · Psychiatrie DX.2

✅ **C** — Poursuivre l'ISRS, réévaluer à 2–6 semaines, associer la TCC

① **Pourquoi c'est juste** Délai d'action des antidépresseurs dans les troubles anxieux : 2 à 6 semaines (HUG). Dix jours sans effet n'est pas un échec. La sueur sous ISRS est un effet iatrogène connu : ne pas la prendre pour un échec du traitement.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La S3 la déconseille sauf exception ; AIPS : 2–3 mois maximum (dépendance).
- **B** Jamais d'arrêt brutal : décroissance ≥ 1–2 semaines.
- **D** Pas d'antisudorifique tant que l'anxiété n'est pas traitée.
- **E** Délai d'action non atteint ; la venlafaxine fait aussi transpirer.

③ **Perle** Sueur iatrogène persistante : réduire la dose, changer de molécule, associer la TCC. Contrôler le QTc sous escitalopram (dose-dépendant).

④ **Source** Phase B DX.2 §13 · LOT_001 audité

Q33 SPE · Hématologie DX.12

✅ **D** — Radiothérapie de site impliqué sur le résidu

① **Pourquoi c'est juste** Deauville (fixation comparée au médiastin et au foie) : ≤ 3 = réponse métabolique complète ; ≥ 4 = TEP positif. Un résidu actif se consolide par radiothérapie de site impliqué (30 Gy dans le LH).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Réponse complète = Deauville ≤ 3 ; ≥ 4 = TEP positif.
- **B** Non routinière dans le LH ; le TEP l'a remplacée.
- **C** Pas de scanner de surveillance de routine ; ne traite pas le résidu actif.
- **E** Suivi à vie après un LH.

③ **Perle** « Consolider seulement ce qui reste actif. » Diagnostic : biopsie-exérèse ; stade et réponse : TEP-TDM.

④ **Source** Phase B DX.12 §13 · LOT_001 audité

Q34 EX DX.2 vs DX.4

✅ **A** — ECG, glycémie capillaire, signes vitaux et TSH avant de retenir un trouble anxieux

① **Pourquoi c'est juste** Une sueur avec peur ne devient un trouble anxieux qu'après exclusion de l'infarctus, de l'hypoglycémie, de l'hyperthyroïdie et du sevrage : ECG, glycémie capillaire, signes vitaux, TSH.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Une attaque unique ne fait pas un trouble panique ; et la cause organique doit être exclue d'abord.
- **C** La benzodiazépine n'est jamais un traitement de fond des troubles anxieux.
- **D** Sensibilité 0,64 : un score oriente vers l'entretien, il ne pose pas le diagnostic.
- **E** Sueur + palpitations + peur : infarctus, hypoglycémie, hyperthyroïdie et sevrage passent avant.

③ **Perle** Une personne sur cinq vit une attaque de panique : le trouble exige des attaques récurrentes inattendues et un mois de crainte ou de changement de comportement.

④ **Source** Phase B DX.2 §14 · LOT_001 audité

Q35 **EX** DX.3 vs DX.4

✅ **B** — Réduire la dose d'insuline et renforcer l'autosurveillance glycémique

① **Pourquoi c'est juste** Quand un agoniste du GLP-1 ou le tirzépatide est ajouté, l'insuline ou la sulfonylurée doit être réduite et l'autosurveillance renforcée : l'hypoglycémie explique alors des sueurs.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Le risque est l'hypoglycémie : on réduit l'insuline (ou la sulfonylurée).
- **C** Faux : l'association expose à l'hypoglycémie, cause possible de sueurs.
- **D** Pas d'arrêt brutal : réduction et surveillance.
- **E** Il masquerait la tachycardie d'une hypoglycémie et ne traite pas la cause.

③ **Perle** Médicament de l'obésité = toujours avec régime et activité ; arrêt si perte < 5 % au délai fixé par l'AIPS.

④ **Source** Phase B DX.3 §14 · LOT_001 audité

Q36 **EX** DX.5

✅ **C** — Sels d'aluminium (10–30 %) appliqués le soir sur peau sèche

① **Pourquoi c'est juste** Traitement par étapes : sels d'aluminium le soir, puis Axhidrox® (glycopyrronium, aisselles seulement) ou toxine botulique (BOTOX® 50 U ou Dysport® 100 U par aisselle).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Réservée aux formes rebelles ; sudation compensatrice chez 76 à 90 % des opérés.
- **B** Hors indication, après vérification des contre-indications ; pas en première ligne.
- **D** La S1 n'indique aucun examen de routine devant un tableau typique.
- **E** Deuxième étape après échec des sels d'aluminium.

③ **Perle** Éviter la solution alcoolique à l'aisselle. Axhidrox® : indication axillaire seule, pas avant 18 ans ni après 65 ans.

④ **Source** Phase B DX.5 §14 · LOT_001 audité

Q37 EX DX.8 vs DX.2

✅ **D** — Reprendre la dose antérieure puis décroître plus lentement, sur au moins 1 à 2 semaines

① **Pourquoi c'est juste** Sueur après diminution ou arrêt = sevrage. L'AIPS demande une réduction progressive sur au moins 1 à 2 semaines ; si les symptômes sont invalidants, reprendre la dose antérieure puis décroître plus lentement.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La chronologie (après l'arrêt) évoque un sevrage, pas une rechute.
- **B** Pas de traitement de fond par benzodiazépine.
- **C** Symptômes invalidants : reprise puis décroissance lente.
- **E** Le diagnostic est chronologique ; la reprise soulage.

③ **Perle** Datez la sueur : pendant le traitement = effet direct ; après arrêt = sevrage. Ne jamais arrêter brutalement un ISRS ni un agoniste dopaminergique.

④ **Source** Phase B DX.8 §14 · LOT_001 audité

Q38 EX DX.9

✅ **E** — Recherche de paludisme le jour même

① **Pourquoi c'est juste** Le médecin pense au paludisme devant toute fièvre après un séjour tropical, même sous prophylaxie.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** On pense au paludisme devant toute fièvre après un séjour tropical, même sous prophylaxie.
- **B** Ne remplace pas l'exclusion immédiate du paludisme.
- **C** Le cours déconseille de décider du début de l'antibiothérapie sur la procalcitonine.
- **D** Retarder le diagnostic d'un paludisme est dangereux.

③ **Perle** Cherchez d'abord le sepsis (qSOFA ≥ 2, lactate > 2 mmol/L) ; choc → antibiotique dans l'heure.

④ **Source** Phase B DX.9 §13 · LOT_001 audité

Q39 EX DX.10 vs DX.5

✅ **A** — Chercher une cause secondaire avant tout traitement symptomatique

① **Pourquoi c'est juste** Une sueur qui débute après 25 ans, asymétrique, généralisée ou nocturne impose de chercher une cause avant tout traitement symptomatique (DX.10).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Asymétrie, début après 25 ans et sueur nocturne imposent d'abord la recherche d'une cause.
- **C** Traitement symptomatique de la forme primaire, pas d'une sueur asymétrique récente.
- **D** Ne s'emploie qu'après recherche de la cause.
- **E** Les critères ne sont pas remplis (asymétrique, nocturne, début tardif).

③ **Perle** Les critères de Walling (Se 0,99, Sp 0,82) définissent la forme primaire mais n'excluent pas une cause secondaire.

④ **Source** Phase B DX.10 §13 · LOT_001 audité

Q40 EX DX.11

✅ **B** — Sans délai

① **Pourquoi c'est juste** Les contacts de 12 ans ou plus se testent 2 mois après l'exposition ; les enfants de moins de 5 ans sans délai.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Délai des contacts de 12 ans ou plus ; avant 5 ans, on teste sans délai.
- **C** Le dépistage des contacts est systématique.
- **D** Aucun délai de ce type pour un jeune enfant exposé.
- **E** Faux : les moins de 5 ans sont prioritaires.

③ **Perle** Le cas index se déclare dès le début du traitement et reste isolé 5 à 15 jours de traitement efficace.

④ **Source** Phase B DX.11 §13 · LOT_001 audité

Q41 EX DX.12 vs DX.1

✅ **C** — Chercher ménopause, médicaments, thyroïde et apnées, traiter 4 à 8 semaines puis réévaluer

① **Pourquoi c'est juste** Sueurs nocturnes isolées sans ganglion ni perte de poids : on cherche les causes fréquentes, on traite 4 à 8 semaines et on réévalue ; la biopsie s'impose dès qu'une adénopathie, une fièvre ou un amaigrissement apparaît.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Il n'y a aucun ganglion à biopsier ni symptôme B complet.
- **B** Pas de TEP de dépistage sans orientation.
- **D** Aucune indication.
- **E** Les symptômes B exigent fièvre > 38 °C, sueurs abondantes et/ou perte > 10 % en 6 mois ; et l'histologie fait le diagnostic.

③ **Perle** Sueurs + adénopathie, fièvre ou perte de poids → biopsie du ganglion en entier sans délai.

④ **Source** Phase B DX.12 §14 · LOT_001 audité

Q42 EX DX.15

✅ **D** — NT-proBNP et échocardiographie à la recherche d'une cardiopathie carcinoïde

① **Pourquoi c'est juste** Le NT-proBNP et l'échocardiographie dépistent la cardiopathie droite (tricuspide et pulmonaire), longtemps silencieuse, chez tout patient avec syndrome carcinoïde.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** La clinique est peu sensible ; la cardiopathie reste longtemps silencieuse.
- **B** La cardiopathie carcinoïde est valvulaire (tricuspide, pulmonaire), pas coronarienne.
- **C** Ne dépiste pas une atteinte valvulaire droite.
- **E** Explore le phéochromocytome, pas la cardiopathie carcinoïde.

③ **Perle** Le syndrome carcinoïde naît surtout de métastases hépatiques : le foie inactive les hormones portales.

④ **Source** Phase B DX.15 §14 · LOT_001 audité

Q43 EX DX.13 × DX.4

✅ **B** — Glucose IV

① **Pourquoi c'est juste** Le glucagon est contre-indiqué dans le phéochromocytome (AIPS GlucaGen®) : il déclenche une crise. Patient suspect + hypoglycémie = glucose.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Contre-indiqué : libère des catécholamines, crise hypertensive.
- **C** Même molécule, même contre-indication.
- **D** Patiente inconsciente : aucune voie orale.
- **E** Ne corrige pas l'hypoglycémie.

③ **Perle** Éviter aussi chez le suspect : métoclopramide, corticostéroïdes, morphine.

④ **Source** Phase B DX.13 §14 · LOT_001 audité

Q44 SPE · Endocrinologie DX.13

✅ **E** — Alpha-bloquant, puis bêtabloquant si besoin

① **Pourquoi c'est juste** Toujours bloquer α avant β, 7–14 jours avant l'opération. Propranolol (60 mg/j 3 jours avant) seulement après l'alpha-bloquant ; le blocage préopératoire relève de l'endocrinologue.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Laisse la vasoconstriction alpha sans opposition : crise.
- **B** Contre-indiqué : épisodes hypertensifs sévères.
- **C** Expose à une crise peropératoire.
- **D** Le glucagon peut déclencher une crise.

③ **Perle** « Jamais de bêtabloquant seul » devant tout phéochromocytome non traité.

④ **Source** Phase B DX.13 §13 · LOT_001 audité

Q45 EX DX.6 × DX.4

✅ **A** — Glucose IV sans délai, en associant la thiamine

① **Pourquoi c'est juste** Hypoglycémie chez un alcoolique carencé : corriger sans délai par glucose IV et associer la thiamine (risque de Wernicke).

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Agit peu sans réserve en glycogène (jeûne, alcool).
- **C** Retarder la correction d'une hypoglycémie est dangereux.
- **D** Ne traite pas l'hypoglycémie.
- **E** Confusion : déglutition non sûre.

③ **Perle** Le glucagon est inefficace après jeûne prolongé, alcool ou insuffisance surrénale.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_001 audité

Q46 SPE · Oncologie (TNE) DX.15

✅ **D** — Nouveau dosage après éviction encadrée

① **Pourquoi c'est juste** ISRS, paracétamol et aliments sérotoninergiques faussent le 5-HIAA. Toute suspension médicamenteuse relève d'un ordre médical ; deux collectes de 24 h.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** Un dosage élevé isolé, sous interférents, ne suffit pas.
- **B** Localiser seulement après une biologie fiable.
- **C** Ne répond pas à la question du flush.
- **E** Ne répond pas au résultat discordant.

③ **Perle** Le diagnostic exige symptômes + biologie ; ni l'un ni l'autre seul.

④ **Source** Phase A §14 Pièges · LOT_001 audité

Q47 SPE · Cardiologie DX.14

✅ **D** — Échocardiographie transœsophagienne

① **Pourquoi c'est juste** Sur prothèse, l'ETT manque souvent la maladie : ETO, répétée à 5–7 jours si la suspicion reste forte. Équipe d'endocardite.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** ETT normale + absence de souffle n'excluent pas.
- **B** Délai inadapté à une infection endovasculaire.
- **C** Hors sujet.
- **E** N'explore pas l'endocardite.

③ **Perle** Critères : 2 majeurs, ou 1 majeur + 3 mineurs, ou 5 mineurs (ESC / Duke-ISCVID 2023).

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_001 audité

Q48 EX DX.1 × DX.10

✅ **A** — Recherche d'une infection et d'un lymphome

① **Pourquoi c'est juste** Fièvre objectivée ou perte de poids involontaire avec sueurs nocturnes = exclure d'emblée infection grave (TB, endocardite, VIH) et lymphome : examen ganglionnaire, hémogramme, CRP, TSH, IGRA/radio, VIH.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Fièvre + amaigrissement : jamais conclure « ménopause ».
- **C** Traite un symptôme sans écarter une cause grave.
- **D** Même erreur : cause somatique non exclue.
- **E** Masquerait des signes généraux.

③ **Perle** Les symptômes vasomoteurs se posent après exclusion, jamais avec fièvre ou amaigrissement.

④ **Source** Phase B DX.10 §14 · LOT_001 audité

Q49 SPE · Dermatologie DX.5

✅ **D** — Sympathectomie thoracique en première intention

① **Pourquoi c'est juste** Traitement par étapes : mesures générales + sels d'aluminium, puis glycopyrronium topique ou toxine. La sympathectomie est réservée aux formes rebelles.

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** 1re étape recommandée, simple et réversible.
- **B** Mesure générale associée.
- **C** 2e ligne autorisée (Axhidrox®).
- **E** 2e ligne (BOTOX® 50 U/aisselle).

③ **Perle** Sympathectomie : sudation compensatrice chez 76–90 % des opérés (sévère chez 22 %).

④ **Source** Phase B DX.5 §13 · LOT_001 audité

Q50 EX DX.7

✅ **E** — Arrêter le carbimazole et faire un hémogramme immédiatement

① **Pourquoi c'est juste** Sous thyréostatique, fièvre, mal de gorge ou aphtes imposent l'arrêt du médicament et un hémogramme le jour même (agranulocytose).

② **Pourquoi pas les autres**

- **A** L'agranulocytose débute en heures ou en jours : on n'attend pas.
- **B** Il faut d'abord exclure l'agranulocytose et arrêter le thyréostatique.
- **C** Ne répond pas au risque d'agranulocytose.
- **D** Ce n'est pas la conduite d'urgence ; l'urgence est l'hémogramme.

③ **Perle** L'information du patient protège plus qu'un hémogramme hebdomadaire. Bêtabloquant : effet en heures ; thyréostatique : 3 à 6 semaines.

④ **Source** Phase B DX.7 §14 · LOT_001 audité

Q51 EX DX.14

✅ **A** — Ajouter un test moléculaire du VIH (ARN)

① **Pourquoi c'est juste** Un test de 4e génération négatif à 3 semaines n'exclut pas le VIH : fenêtre de 6 semaines ; ajouter un test moléculaire, sans test rapide.

② **Pourquoi pas les autres**

- **B** Fenêtre jusqu'à 6 semaines : le test de 4e génération peut encore être négatif.
- **C** Pas de test rapide dans cette situation.
- **D** Retarde le diagnostic et le traitement.
- **E** La primo-infection VIH doit être exclue.

③ **Perle** Tout test positif se confirme sur le même échantillon et se déclare obligatoirement ; tout patient VIH reçoit un traitement quel que soit le taux de CD4.

④ **Source** Phase B DX.14 §14 · LOT_001 audité